

Manual de Procedimientos Operacionales Estándar y Cumplimiento Regulatorio para Contact Centers del Sector Salud (EPS, IPS, Clínicas)

El presente informe establece los lineamientos operativos y el marco regulatorio indispensable para los Contact Centers que prestan servicios de aseguramiento y prestación de salud (EPS, IPS, Hospitales, Clínicas). El objetivo es estandarizar la atención al usuario, garantizando la calidad, la oportunidad y el estricto cumplimiento de las normativas vigentes en materia de salud y protección de datos personales.

I. INTRODUCCIÓN Y MARCO DE CUMPLIMIENTO LEGAL OPERACIONAL

La línea de atención telefónica actúa como el primer punto de contacto entre la entidad de salud y el usuario, por lo que su operación está intrínsecamente ligada al cumplimiento de los estándares de calidad definidos por el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) de Colombia.

1.1. Principios de la Calidad y el Deber de Oportunidad

El servicio proporcionado por el Call Center debe ser un facilitador de la atención médica. El marco regulatorio exige que las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) garanticen la prestación de servicios bajo criterios de accesibilidad, seguridad, pertinencia, continuidad y, fundamentalmente, **oportunidad**.¹

La Oportunidad se define como la posibilidad que tiene el usuario de obtener la prestación de

servicios que requiere, sin que se presenten retrasos que pongan en riesgo su vida o generen mayores complicaciones. En este contexto, el Call Center no solo programa, sino que realiza un primer filtro de clasificación de riesgo.

Es obligatorio que los agentes estén capacitados para identificar solicitudes que requieran una **Atención Oportuna o Consulta Prioritaria**, en lugar de una cita programada. Esta función se alinea con la Resolución 5596 de 2015, que define los criterios técnicos para el sistema de selección y clasificación de pacientes en los servicios de urgencias, conocido como "TRIAGE".¹ Aunque el agente no aplica el Triage clínico, sí debe derivar correctamente al canal apropiado (urgencias, atención domiciliaria), lo que constituye una estrategia para manejar eficientemente el incremento de la demanda y asegurar la continuidad de la atención.¹

1.2. Marco de Protección de Datos Personales en Salud (Habeas Data)

La información de salud es considerada información sensible. Por ende, el manejo de datos en el Call Center está regido por la legislación de Habeas Data, la cual consagra el derecho individual a acceder, controlar y corregir la información relativa a su esfera más íntima: la salud.²

1.2.1. Implicaciones de la Confidencialidad

Para el Call Center, el cumplimiento de Habeas Data es un pilar operacional. La infraestructura tecnológica, incluyendo la grabación de llamadas³ y el acceso a bases de datos⁴, debe garantizar la máxima confidencialidad. Cualquier divulgación no autorizada de la Información de Salud Protegida (PHI, por sus siglas en inglés) es una violación que puede acarrear sanciones impuestas por la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud).⁵

El proceso de verificación de identidad (Sección II) trasciende la mera administración, convirtiéndose en el principal control de seguridad para evitar la divulgación ilegal de PHI. La entidad debe proteger y respetar la privacidad de los datos personales, y cada agente debe internalizar que su función implica actuar como un "Guardia de la Data de Salud".⁶ La capacitación en este marco legal es obligatoria y debe preceder cualquier inicio de operaciones.

II. PROTOCOLO GENERAL DE LA LLAMADA Y VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD (PPI)

El Protocolo de Identificación Positiva del Paciente (PPI) es la piedra angular para el cumplimiento de Habeas Data y el inicio formal de cualquier gestión operativa.

2.1. Apertura: Saludo, Presentación y Establecimiento de Confianza

El protocolo de atención debe seguir una secuencia rigurosa para establecer profesionalismo y confianza.⁷

1. **Saludo Institucional y Presentación del Agente:** Iniciar con un saludo claro que incluya el nombre de la compañía (EPS/IPS) y el nombre del agente. *Ejemplo: "Gracias por llamar a [Nombre de la entidad]. Le atiende [Nombre del Agente]. ¿Con quién tengo el gusto de hablar?"*
2. **Consulta Inicial de la Solicitud:** El agente debe preguntar de forma activa y clasificar la solicitud inmediatamente (Agendamiento, Autorización, PQRS, Consulta General).⁴ Esto permite dirigir el flujo de la llamada y preparar la información necesaria.

2.2. Paso Crítico: Verificación de Identidad del Paciente (PPI)

Antes de acceder a la historia clínica, agendar una cita o divulgar cualquier información sensible, se debe verificar que el interlocutor es el titular de los datos o un apoderado legalmente autorizado.⁸

Datos de Identificación Obligatorios:

1. **Tipo de Documento:** Cédula de Ciudadanía, Tarjeta de Identidad, Pasaporte, Cédula de Extranjería, u otro Número Único de ID.⁶
2. **Número de Documento:** Dato fundamental para la búsqueda precisa en las bases de datos de afiliación.⁴
3. **Datos de Validación Cruzada:** Se debe solicitar al menos un dato adicional, como la Fecha de Nacimiento o la Dirección registrada, para confirmar la identidad y mitigar el riesgo de suplantación.

Procedimiento de Búsqueda: Una vez obtenidos los datos, el agente debe proceder a buscar el paciente en el sistema. Esta búsqueda confirma no solo la identidad, sino también la disponibilidad de servicio y el régimen de afiliación (Contributivo o Subsidiado).⁴

2.3. Desarrollo y Gestión de Solicitudes

Toda la interacción y la información capturada durante la llamada (incluyendo el Motivo de Consulta y las instrucciones dadas) deben ser registradas en el sistema de gestión del paciente (CRM o HCE).³

Transferencia de Llamadas: Si el agente inicial no puede resolver la solicitud, se debe realizar una transferencia informada. El agente debe explicar claramente al paciente que será transferido y proporcionar un contexto conciso al colega o departamento receptor (ej. Coordinación Médica, Autorizaciones) para evitar que el paciente deba repetir la información ya suministrada. Esto mejora la experiencia y reduce la fricción.⁷

2.4. Cierre y Resumen

1. **Recapitulación:** Se debe resumir la acción completada (ej. "Para resumir, hemos agendado su cita para el 15 de marzo a las 10 a.m. con el Dr. Pérez").⁷
2. **Despedida:** Concluir agradeciendo la llamada y ofreciendo asistencia futura.⁷

III. PROTOCOLO OPERACIONAL 1: AGENDAMIENTO DE CITAS MÉDICAS

El agendamiento eficiente es la principal manifestación del principio de Oportunidad.¹ Este protocolo detalla la recopilación de los datos obligatorios requeridos para la gestión administrativa y la pertinencia clínica.

3.1. Flujo Detallado para Agendar Citas (Medicina General y

Especializada)

Paso A: Verificación de Identidad (PPI)

Completar rigurosamente la verificación de identidad según la Sección 2.2.

Paso B: Recolección de Datos Fundamentales (Datos de Cita Obligatorios)

El Call Center debe recopilar los siguientes datos, que son críticos para la trazabilidad y el cumplimiento regulatorio:

1. **Cédula de Ciudadanía/ID:** Ya verificada, utilizada para acceder y registrar en la HCE.
2. **Motivo/Razón de la Consulta: Dato Crítico.** Este detalle es fundamental para clasificar la cita por pertinencia y determinar si requiere ser asignada a una Consulta Prioritaria o a un especialista específico.¹ La captura debe ser específica (ej. "Control anual", "Dolor lumbar persistente", "Valoración de resultados de laboratorio").
3. **Verificación de la Orden Médica:** Se debe solicitar la fecha de la orden y, si es una consulta especializada que requiere remisión, el número de autorización para verificar la vigencia de la orden.⁴
4. **Confirmación de Cobertura:** Validar el régimen de afiliación y los requisitos de co-pago o cuotas moderadoras.

Paso C: Gestión de Agendas y Oportunidad

1. Consultar la disponibilidad en el sistema de control de agendas, asegurando la concordancia entre la disponibilidad del médico y, si aplica, los equipos de diagnóstico requeridos.¹¹
2. Ofrecer las fechas más próximas disponibles, procurando el cumplimiento de los tiempos máximos de espera establecidos.
3. Confirmar la **Fecha y Hora de la Cita** y registrarla en el sistema.

Paso D: Instrucciones Finales

Informar al paciente sobre: la documentación obligatoria (ID, órdenes, autorizaciones), la ubicación de la IPS, y la recomendación de llegar con al menos 10 minutos de anticipación para el proceso administrativo de ingreso.¹²

Tabla 1: Datos Mínimos y Propósito de Cumplimiento en el Agendamiento

Dato Requerido por el Agente	Propósito Operacional	Requisito de Cumplimiento
Cédula de Ciudadanía (ID)	Autenticación y acceso a la HCE.	Habeas Data (Confidencialidad), Identificación Positiva del Paciente. ⁶

Fecha y Hora de la Cita	Registro formal del compromiso de prestación.	Oportunidad y Accesibilidad del Servicio (Supersalud). ¹
Razón / Motivo de Consulta	Clasificación de riesgo y asignación de especialista (Pertinencia).	Triage, Consulta Prioritaria (Resolución 5596/2015). ¹

3.2. Variante Común: Gestión de Lista de Espera

Cuando la demanda supera la capacidad de atención inmediata o no existe disponibilidad para la fecha deseada por el usuario (particularmente en consultas especializadas), se debe activar el protocolo de Lista de Espera.¹¹

Procedimiento:

1. Registrar la solicitud, incluyendo la fecha y hora deseada originalmente, en la Lista de Espera.
2. Informar al paciente sobre el proceso y el tiempo estimado de contacto (ej. "Le contactaremos si se abre un espacio por cancelación").
3. Ofrecer alternativas, como el servicio de Telemedicina (E-Consultation) para una primera valoración, si la entidad lo ofrece, como una estrategia para asegurar el acceso al especialista o mitigar la espera.¹³

3.3. Situación de Ejemplo 1: Script de Agendamiento Exitoso

Escenario: Paciente "María Torres" llama para solicitar una cita de control con Ginecología.

- **Agente:** "Para programar su cita, ¿podría indicarme su número de Cédula de Ciudadanía para verificar su identidad?" (Cumplimiento Habeas Data)
- **Agente:** "Gracias, señora Torres. Hemos verificado su afiliación. Ahora, por favor, indíqueme brevemente, ¿cuál es el motivo de su consulta?" (Clasificación por Pertinencia)
- **Agente:** "Entendido. La agenda más cercana con la Dra. Ramírez en la IPS Central es el miércoles [Fecha] a las 11:30 a.m. ¿Le es conveniente?" (Gestión de Oportunidad)
- **Agente (Cierre):** "Su cita ha quedado agendada en nuestro sistema. Por favor, recuerde traer su Cédula de Ciudadanía y la orden de remisión. ¿Desea que le enviemos la confirmación por [canal digital]?"

IV. PROTOCOLO ESPECIALIZADO 2: OFTALMOLOGÍA Y OPTOMETRÍA

El agendamiento de citas en las áreas visuales requiere la implementación de protocolos pre-clínicos estrictos para garantizar la validez y la pertinencia del examen. El incumplimiento de la preparación previa puede invalidar el examen, obligando a una re-consulta y generando costos operativos y frustración en el usuario.

4.1. Clasificación y Tipos de Consultas Visuales

El agente debe clasificar la solicitud para asignar al profesional adecuado: Oftalmólogo (médico especialista) u Optómetra (revisión de agudeza visual y prescripción de lentes).¹⁵

- **Oftalmología:** Se agenda por clasificación (Consulta Nueva, Re Consulta, Seguimientos, Post Operatorios).¹⁰ El motivo de consulta determina la subespecialidad requerida.
- **Optometría:** Se agenda para revisión de agudeza visual, Graduación Final, Consulta Rx, Medición de Anillos o Prótesis.¹⁰

Recolección de Data Clínica Crítica: Durante la gestión, es obligatorio recopilar datos relevantes que serán de utilidad para el especialista: Edad del paciente, si padece de Diabetes o Hipertensión, si usa gafas, y si es usuario de Lentes de Contacto (LC).¹⁰

4.2. Pasos Específicos y Pre-Instrucciones para Lentes de Contacto (LC)

El paso más crítico es la notificación y confirmación del retiro de lentes de contacto. Esta instrucción pre-clínica es un control de calidad para garantizar la **Pertinencia** de la atención oftalmológica. Si el paciente no retira los LC, la forma natural de la córnea puede estar alterada, resultando en mediciones inexactas y, por ende, un diagnóstico o prescripción errónea.

Paso 1: Verificación de Uso de LC: Si el paciente confirma el uso, el agente debe preguntar

por el tipo (Rígido o Blando).¹⁰

Paso 2: Instrucción Clínica Obligatoria: El agente debe notificar al paciente, de forma clara, el protocolo de retiro según el tipo de lente y obtener la confirmación de entendimiento por parte del usuario.

Tabla 2: Protocolo de Preparación Previa Obligatoria (Lentes de Contacto)

Tipo de Lente de Contacto	Instrucción de Retiro Obligatoria	Tiempo de Retiro Mínimo	Fundamento Clínico (Pertinencia)
Lente de Contacto Rígido (LC Rígido)	Retirar los lentes de contacto.	48 horas antes de la cita ¹⁰	Permitir que la córnea recupere su curvatura natural.
Lente de Contacto Blando (LC Blando)	Retirar los lentes de contacto.	24 horas antes de la cita ¹⁰	Reducir la hidratación y alteración temporal de la superficie corneal.

4.3. Situación de Ejemplo 2: Script de Agendamiento en Optometría con Instrucciones Previas

Escenario: Paciente "Carlos Ríos" llama solicitando un examen de Optometría.

- **Agente:** "Señor Ríos, hemos agendado su cita. Para el examen, ¿utiliza lentes de contacto?"
- **Paciente:** "Sí, uso unos blandos de uso mensual."
- **Agente:** "Entendido. Es indispensable que retire los lentes de contacto blandos al menos **24 horas** antes de la hora de su cita. ¿Ha comprendido la instrucción?"
- **Agente (Registro):** El agente debe registrar la instrucción como "LC Blando - Instrucción de Retiro 24h Confirmada" para trazabilidad clínica.

V. PROTOCOLO OPERACIONAL 3: SOLICITUD DE

AUTORIZACIONES MÉDICAS

Las llamadas relacionadas con la Autorización Previa (PA, del inglés *Prior Authorization*) de servicios son frecuentemente un punto de tensión. El agente debe manejar el flujo con precisión administrativa.

5.1. Proceso de Solicitud de Autorización Previa (PA)

La Autorización Previa es la aprobación administrativa requerida para que ciertos servicios o medicamentos puedan ser cubiertos por la entidad de salud.¹⁶

Paso A: Identificación del Requisito

El agente debe consultar la base de datos de cobertura para verificar si el servicio solicitado (identificado por el código CUPS y el diagnóstico CIE-10) requiere una PA.

- **Nota de Variación:** El agente debe estar consciente de las variaciones regulatorias. Por ejemplo, en el Régimen Subsidiado, la atención de Médico General puede no requerir autorización, sino únicamente la verificación de la afiliación en la base de datos.⁹

Paso B: Captura de Datos de la Orden Médica

Se debe registrar la información completa de la orden: Médico tratante, Código del Servicio, Diagnóstico, y la fecha de la solicitud.

Paso C: Registro y Radicación

El agente debe ingresar la solicitud formalmente en el sistema de autorizaciones y proporcionar al paciente un número de radicado o de seguimiento.

5.2. Seguimiento y Notificación de la Decisión

Si el paciente llama para consultar el estado de su solicitud, el agente debe:

1. Realizar la PPI rigurosamente.⁸
2. Consultar el estado utilizando la ID del paciente o el número de radicado.
3. Notificar la resolución (Aprobada, Negada, o En Proceso).

Notificación de Aprobación: Si se aprueba, se debe suministrar el número de autorización final y las instrucciones logísticas (ej. IPS asignada, fecha de entrega de medicamentos).¹⁷ La entidad también tiene la obligación de notificar formalmente al médico tratante y, en muchos

casos, al paciente por vía escrita.¹⁷

5.3. Situación de Ejemplo 3: Llamada a Preguntar sobre el Estado de una Autorización

Escenario: Paciente llama preguntando por la autorización para una Resonancia Magnética.

- **Agente:** "Señora Martínez, tras verificar su identidad, consulto el estado de su radicado. La solicitud para la Resonancia Magnética ha sido **Aprobada**. El número de autorización es [Número]. Ya hemos notificado a la IPS [Nombre] para que procedan con el agendamiento. ¿Tiene alguna otra pregunta sobre el proceso?"
 - **Agente (Variante Negación):** "Señor Gómez, lamentablemente, la solicitud ha sido **Negada** debido a que [Motivo Específico, ej. El procedimiento solicitado no está cubierto por su plan de beneficios]. Hemos generado el documento de negación formal. Procedo a registrar su inconformidad y a orientarle sobre sus derechos de reclamación (Sección VI.2)."
-

VI. MANEJO DE VARIANTES Y EXCEPCIONES OPERATIVAS

La gestión efectiva de las excepciones y variantes reduce la fricción del usuario y mitiga el riesgo de escalamiento legal y judicial.

6.1. Variantes en el Agendamiento

6.1.1. Variante A: Paciente No Encontrado en Base de Datos

Si la verificación de la Cédula/ID es correcta, pero el paciente no aparece en la base de datos de afiliación, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Verificar la correcta digitación de los datos.⁶
2. Si el paciente insiste en estar afiliado, se debe escalar internamente el caso al área de Afiliaciones y, simultáneamente, orientar al usuario para que consulte su estado de afiliación ante la EPS o la ADRES.

6.1.2. Variante B: Solicitud de Consulta Prioritaria o Manejo de Urgencias

Si el Motivo de Consulta revela un riesgo de salud que requiere atención inmediata, el agente debe proceder a realizar un **Triage Telefónico** no clínico.

1. **Detección de Riesgo:** El agente debe identificar síntomas graves (ej. dolor de pecho, dificultad respiratoria, sangrado profuso).
2. **Escalada:** Aplicar el protocolo de escalada inmediata a la ruta de atención prioritaria (ej. servicio de urgencias, línea de atención médica domiciliaria).¹ El Call Center debe garantizar la eliminación de barreras de acceso a la referencia y contrareferencia de pacientes.¹

6.2. Variante Crítica: Negación de Servicios o Incumplimiento (El Agente como Orientador Legal)

La negación de un servicio o el incumplimiento en su prestación es la principal causa de conflicto. La correcta orientación por parte del agente es un factor mitigador clave contra la judicialización del caso (Acción de Tutela).

Paso 1: Registro de la Queja/Reclamo (PQRS)

Ante la inconformidad, el agente está obligado a registrar formalmente el caso en el sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos o Sugerencias (PQRS). La entidad debe dar una respuesta formal, argumentada y con las pruebas pertinentes, en un término máximo de 15 días hábiles.⁵

Paso 2: Orientación sobre los Recursos de Ley

Si el conflicto persiste, el agente debe orientar al usuario sobre los recursos legales disponibles ante terceros, sin ofrecer asesoría jurídica.

- **Queja o Denuncia ante la Supersalud:** Puede presentarse si la entidad incumplió una norma o prestó el servicio de manera inadecuada.⁵ La Supersalud puede ordenar la prestación del servicio y aplicar sanciones o multas.⁵
- **Demanda Jurisdiccional ante la Supersalud:** Para conflictos específicos, como la negación de cobertura del Plan Obligatorio de Salud (POS), reembolsos económicos o

conflictos de libre elección.⁵ En estos casos, la Supersalud actúa como **Juez de la República**.⁵ El usuario solo necesita un abogado si el valor reclamado supera los 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV).⁵

- **Acción de Tutela:** Recurso extremo aplicable cuando la vida o la salud del paciente están en peligro o cuando se trata de personas de especial protección constitucional. Este recurso se presenta ante un Juez de la República, no tiene costo y no requiere abogado.¹⁸ El juez tiene un plazo de 10 días para tomar una decisión.¹⁸

La gestión proactiva de conflictos, facilitando el recurso de PQRS interno, está diseñada para reducir la probabilidad de que el caso escale a una Acción de Tutela, la cual sobrecarga el sistema judicial y representa una falla en el deber de la entidad de garantizar la atención. La calidad del manejo de conflictos se convierte, por lo tanto, en una métrica de riesgo legal para la entidad.

Tabla 3: Guía de Gestión de Conflictos y Orientación Legal al Usuario

Variante Operacional	Acción Inicial del Agente	Ruta de Orientación (Recurso Legal)	Requisito de Abogado/Costo
Negación de Cobertura (POS) o Reembolso	Registrar PQRS, comunicar negación formal y sus motivos.	Demanda ante Supersalud (Función Jurisdiccional). ⁵	Abogado si la cuantía supera 40 SMMLV. ⁵
Incumplimiento o Mala Prestación de Servicio	Recibir y documentar la Queja/Denuncia.	Queja/Denuncia ante Supersalud (Inspección y Vigilancia). ⁵	No requiere abogado.
Riesgo Inminente a la Salud o Vida	Escalada inmediata a la Ruta de Atención Prioritaria (Triage).	Acción de Tutela (protección de derechos fundamentales). ¹⁸	No requiere abogado. Trámite sin costo. ¹⁸

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE CALIDAD

La implementación exitosa de estos protocolos requiere una supervisión constante y la correlación entre las métricas operacionales del Call Center y los resultados de cumplimiento normativo y clínico de la entidad.

7.1. Indicadores de Gestión Críticos (KPIs)

Para medir la eficiencia y el cumplimiento, se deben establecer los siguientes Indicadores de Gestión Críticos:

1. **Tasa de Oportunidad de la Cita:** Porcentaje de citas programadas que cumplen con los tiempos máximos de espera establecidos por la Supersalud.
2. **Tasa de Identificación Positiva (PPI) Exitosa:** Mide el porcentaje de llamadas en las que el protocolo de Habeas Data (verificación de identidad) se cumple totalmente.
3. **Tasa de Cumplimiento de Instrucciones Pre-Cita (Oftalmología):** Mide la efectividad del agente en comunicar los requisitos de retiro de LC (48h/24h).¹⁰ Este indicador tiene un impacto directo en la **Pertinencia** clínica, ya que reduce la tasa de re-consultas por exámenes fallidos.
4. **Índice de Recurso Legal (IRL):** Número de PQRS internas que escalan a una Queja/Demanda formal ante la Supersalud o resultan en una Acción de Tutela. Un IRL bajo indica una gestión de conflictos interna eficiente (Sección VI).
5. **Efectividad en la Gestión de Lista de Espera:** Mide la rapidez con la que los pacientes en lista de espera son contactados y agendados.¹¹

7.2. Recomendaciones para el Entrenamiento Continuo del Personal

El ambiente regulatorio y clínico del sector salud es dinámico, por lo que la formación continua es esencial.

Entrenamiento Operativo y de Calidad:

- **Monitoreo y Grabación de Calidad:** Se recomienda utilizar la grabación de llamadas para monitorear la adherencia a los protocolos, especialmente en aspectos de Habeas Data y la detección de riesgos (Triage Telefónico).³
- **Simulacros de Llamadas (Role-Playing):** Implementar ejercicios de simulación para practicar situaciones de alta complejidad o emocionalmente sensibles, como la negación

de una autorización o la solicitud de una consulta prioritaria.¹⁹

Actualización Normativa:

- Es imperativo que el personal reciba actualizaciones periódicas sobre cambios regulatorios. Por ejemplo, las Entidades Administradoras deben promover la implementación de estrategias como la **consulta prioritaria** para manejar eficientemente la demanda, tal como lo establece la Circular Externa 009 de 2024 del Ministerio de Salud y Protección Social, enfocada en la atención oportuna ante incrementos de demanda.¹ Asegurar la disponibilidad y la capacidad instalada para estas estrategias es un deber que inicia en la correcta clasificación de la llamada por el agente.

Obras citadas

1. Circular Externa 009 de 2024 Ministerio de Salud y Protección Social, fecha de acceso: octubre 28, 2025,
<https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=156699>
2. What is Habeas Data, the guardian of health personal data? - Dreyfus.fr, fecha de acceso: octubre 28, 2025,
<https://www.dreyfus.fr/en/2025/09/09/what-is-habeas-data-the-guardian-of-health-personal-data/>
3. Gestión de Llamadas: Estrategias para Mejorar las Prácticas de Telefonía en su Clínica Médica - Medesk, fecha de acceso: octubre 28, 2025,
<https://www.medesk.net/es/blog/gestion-de-llamadas-medicas/>
4. Protocolo Atención de Citas Call Center | PDF - Scribd, fecha de acceso: octubre 28, 2025,
<https://es.scribd.com/document/530326034/PROTOCOLO-ATENCION-DE-CITAS-CALL-CENTER>
5. ¿Qué hacer si no está conforme con el servicio de su EPS o IPS, fecha de acceso: octubre 28, 2025,
<https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/LegalApp/Paginas/Que-hacer-si-no-esta-conforme-con-el-servicio-de-su-EPS-o-IPS.aspx>
6. Habeas data Bogota-en - Bogotá - Reprotec, fecha de acceso: octubre 28, 2025,
<https://reprotectucentro.com/habeas-data-bogota-en/>
7. Call center script examples and best practices - MicroSourcing, fecha de acceso: octubre 28, 2025,
<https://www.microsourcing.com/learn/blog/call-center-script-examples-and-best-practices/>
8. PROTOCOLO CORRECTA IDENTIFICACION DEL PACIENTE, fecha de acceso: octubre 28, 2025,
https://aicsalud.org.co/media/25_ANEXO_7/190010898001/4_PT-SP-02_Protocolo_correcta_identificacion_del_paciente.pdf
9. PROTOCOLO CALL CENTER Código: PT.AU-01 Versión: 02 Página 1 de 25 - ESE Hospital San Vicente de Paúl Caldas, fecha de acceso: octubre 28, 2025,
<https://esehospicaldas.gov.co/wp-content/uploads/2025/09/PT.AU-01-CallCenter>

- [V02.pdf](#)

10. Protocolo atención al cliente - Visualiza, fecha de acceso: octubre 28, 2025, <https://www.visualiza.com.gt/wp-content/uploads/2023/03/PROTOCOLO-CALL-CENTER-ACTUALIZADO-2022-ANEXOS.pdf>
11. Contact Center para Clínicas, IPS y Hospitales | Bogotá CO - dyalogo s.a.s., fecha de acceso: octubre 28, 2025, <https://www.dyalogo.com/servicio-agendamiento-citas-medicas>
12. Guía paso a paso para la programación de citas médicas - Unitek College, fecha de acceso: octubre 28, 2025, <https://www.unitekcollege.edu/es/blog/a-step-by-step-guide-to-medical-appointment-scheduling/>
13. Protocolos de seguridad para Call Centers en Colombia - Top Doctors, fecha de acceso: octubre 28, 2025, <https://www.topdoctors.com.co/articulos-medicos/protocolos-de-seguridad-colombia/>
14. Cómo ayudar a los pacientes a prepararse para la teleconsulta | Telehealth.HHS.gov, fecha de acceso: octubre 28, 2025, <https://telehealth.hhs.gov/es/proveedores/preparando-a-los-pacientes-para-la-tele-salud/ayudar-a-los-pacientes-a-prepararse-para-su-citacion>
15. Consulta oftalmológica: todo lo que necesitas saber - salauno, fecha de acceso: octubre 28, 2025, <https://salauno.com.mx/consulta-oftalmologica-todo-lo-que-necesitas-saber/>
16. Solicitudes de autorización previa para atención médica y medicamentos, fecha de acceso: octubre 28, 2025, <https://espanol.bcbstx.com/starkids/getting-care/prior-authorization-requests>
17. Autorizaciones previas para servicios médicos y de farmacia - Humana, fecha de acceso: octubre 28, 2025, <https://es-www.humana.com/member/member-rights/medical-pharmacy-preauthorizations>
18. ¿Qué puedo hacer si la EPS me niega el tratamiento integral para mi enfermedad?, fecha de acceso: octubre 28, 2025, <https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/LegalApp/Paginas/%C2%BFQu%C3%A9-puedo-hacer-si-la-EPS-me-niega-el-tratamiento-integral-para-mi-enfermedad.aspx>
19. Cómo planear el flujo de trabajo - Telehealth.HHS.gov, fecha de acceso: octubre 28, 2025, <https://telehealth.hhs.gov/es/proveedores/como-planear-el-flujo-de-trabajo>
20. Sample Call Center Script: Medical Office (Pediatric) - Specialty Answering Service, fecha de acceso: octubre 28, 2025, <https://www.specialtyansweringervice.net/wp-content/uploads/call-center-directory/healthcare/medical/Sample-Call-Center-Script-Medical.pdf>